EVALUACIÓN DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD
FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR

Elemento	Descripción
Código	08-05-1.0
Nombre	Porcentaje de personas con sospecha de Enfermedad Renal Crónica no tradicional (ERCnt) que cuentan con la confirmación de cronicidad.
Definición conceptual	En la práctica clínica, según criterio médico, se pueden solicitar pruebas de función renal o proteinuria. Cuando estos estudios evidencian alteraciones, se genera sospecha de Enfermedad Renal Crónica que debe confirmarse mediante una verificación posterior. El propósito de esta ficha técnica es evaluar el seguimiento de los casos que presentan sospecha de ERCnt y que reciben una prueba de control dentro del intervalo de tiempo establecido para confirmar o descartar la cronicidad. La Sospecha de Enfermedad Renal Crónica no tradicional: se define como todo paciente de 10 a 60 años con TFGe <60 ml/min/1.73 m² en una determinación o daño funcional, o estructura renal como lo es la microalbuminuria (IAC ≥30 mg/g) o proteinuria (IPC ≥150 mg/g), alteraciones del sedimento urinario, o en estudios por imágenes, sin la presencia de antecedente de diagnóstico de enfermedad con reconocida asociación con la presencia de ERC (Diabetes, hipertensión, lupus, nefropatía hereditaria, enfermedad autoinmune, uropatía obstructiva, cardiopatía hipertensiva, nefropatía crónica hipertensiva, cardiopatía y nefropatía crónica hipertensiva, malformaciones congénitas, poliquistosis renal, anemia drepanocítica, vasculitis y mieloma), ni presencia de lesión renal aguda o Enfermedad Renal Aguda, demostrada al momento del diagnóstico. Prueba de seguimiento oportuno: Realización de una prueba de creatinina sérica, IAC o IPC, entre los 90 y 119 días, ya sea previa o posterior al resultado inicial alterado. Incluye: • Personas de 10 a 60 años que presentan sospecha de ERCnt entre los 118 días previos al inicio del periodo evaluado y los 119 días anteriores a su finalización (por ejemplo, entre el 4 de septiembre del año previo y el 3 de septiembre del año evaluado). Estas personas constituyen la población a la que corresponde realizar la prueba de seguimiento durante el periodo evaluado. • Pruebas de laboratorio clínico para seguimiento oportuno, con fecha de toma de muestra y resultado registrados, dentro del periodo evaluado. Excluye: • Personas de 10 a 60 años con sospecha de ERC con Diabetes mellitus (E10–14), Enfermedades hipertensivas (I10–I15), Nefropatía hereditaria no clasificada en otra parte (N07), Enfermedades autoinmunes sistémicas del tejido conjuntivo (M30-M36), Uropatía obstructiva y por reflujo (N13), Malformaciones congénitas del sistema urinario (Q60–Q64), Trastornos falciformes (D57), Mieloma múltiple y tumores malignos de células plasmáticas (C90). • Personas de 10 a 60 años con diagnóstico de ERC (CIE-10 N18.0–N19) registrado en el año anterior.

EVALUACIÓN DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD
FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR

Variables involucradas en la medición	• Personas de 10 a 60 años que presentan sospecha de ERCnt con prueba de seguimiento oportuno en el periodo. • Personas de 10 a 60 años que presentan sospecha de ERCnt en el periodo.	
Fórmula de cálculo	$\frac{\text{Personas de 10 a 60 años que presentan sospecha de ERCnt con prueba de seguimiento oportuno en el periodo}}{\text{Personas de 10 a 60 años que presentan sospecha de ERCnt en el periodo}} \times 100$	
Desagregación	Nivel de atención	Primer Nivel
	Componente de la prestación	Consulta externa
	Componente de la atención integral	Prevención
	Temática	Enfermedades Crónicas no Transmisibles - ERC
Línea base	A definir con los resultados del análisis 2026 de la Evaluación de la Prestación de Servicios de Salud.	
Meta	Quinquenal: En construcción.	
Periodicidad	Anual	
Fuente de información	Expediente Digital Único en Salud (Cubo DCSS EPSS Cardiovascular, Cubo DCSS EPSS Generales, Reporte HT) • Consultas de primera vez por HT y/o DM2 • Consultas en el año anterior por ERC, y diagnósticos con reconocida asociación a ERC. • Pruebas de laboratorio clínico registradas en el énfasis correspondiente que cuenten con fecha y resultado. Sistemas de laboratorio clínico (LABCORE, Sistema Integrado de Laboratorio Clínico). • Creatinina sérica, IAC ó IPC. Fuente alternativa de resultados de laboratorio clínico	
Clasificación	Indicador de Proceso	
Presentación de resultados	• Reporte de resultados de la Evaluación de la Prestación de Servicios de Salud del Primer Nivel de Atención (anual y monitoreo) • Informe de la Evaluación de la Prestación de Servicios de Salud del Primer Nivel de Atención (anual)	
Comentarios generales	La evaluación se centra exclusivamente en las pruebas bioquímicas fundamentales para valorar la función renal, sin incorporar estudios complementarios ni hallazgos del sedimento urinario, análisis histológicos o pruebas de imagen.	